

Visado

ABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR DE ENFERMERÍA EN SALUD COMUNITARIA

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

I.1. Área académica	Especialidad
I.2. Facultad	Enfermería
I.3. Programa de estudios	Enfermería
I.4. Departamento Académico	Salud Familia y Comunitaria
I.5. Sede / Filial	Trujillo
I.6. Año y semestre académico	2025-II
I.7. Ciclo	VIII
I.8. Código de la asignatura	4234
I.9. Sección (es)	1
I.10. Créditos	9 (T= 3 horas. L= 2 horas. P= 10 horas)
I.11. Prerrequisito	Metodología del cuidado de enfermería. Tecnologías para el cuidado.
I.12. Inicio-Término	11.08.2025 – 28.11.2025
I.13. Tipo	Obligatorio
I.14. Organización semestral del tiempo (semanas)	

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	46	15	15	16
Laboratorio	32	10	10	12
Prácticas	159	50	50	59
Retroalimentación	03	01	01	01
Total Horas	240	76	76	88

1.14. Docente / equipo docente (s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	CORREO INSTITUCIONAL
Coordinadora	Dra. Violeta Fredesminda González y González	Enfermera	vgonzalez@unitru.edu.pe
Docente 1	Mg. Jenny María Estela Milla Risco de Gutiérrez	Enfermera	jmilla@unitru.edu.pe

Visado

Docente 2	Dra. Rossina Dany de la Rosa Condormango	Enfermera	rdelarosac@unitru.edu.pe
Docente 3	Dr. Carlos Alberto Tello Pompa	Enfermera	ctello@unitru.edu.pe
Docente 4	Ms. Eliana Patricia Sandoval Salinas	Enfermera	esandoval@unitru.edu.pe
Docente 5	Ms. Liliana del Carmen Torres Abanto	Enfermera	liliana.torres abanto@gmail.com

II. SUMILLA

La experiencia curricular de Enfermería en salud comunitaria es de carácter teórico – práctico, contribuye al logro de las capacidades terminales del cuidado integral a la comunidad para contribuir al desarrollo social con perspectiva transdisciplinaria, transectorial y gubernamental y las capacidades funcionales dirigidas al cuidado de la comunidad para contribuir al desarrollo social autogestionario con perspectiva transdisciplinaria, transectorial y gubernamental utilizando el proyecto comunitario considerando las políticas públicas, interculturalidad, enfoque de género, respeto de derechos humanos, construcción de ciudadanía, fomento de una ecología sostenibles y la participación social.

La experiencia curricular será útil para que el estudiante logre habilidades y destrezas en la valoración de la comunidad, elaboración de diagnóstico de enfermería socio sanitarios; diseño de planes y proyectos socio sanitarios, utilizando el proyecto comunitario con participación social.

Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades:

- I. **Enfoque teóricos y políticas en la salud comunitaria:** Teorías y Modelos de salud comunitaria.; Desarrollo Humano, Modelo económico social, ecológico, político, histórico socio antropológico. Programas y políticas sociales en el Perú. Lineamientos de política de desarrollo e inclusión social.
- II. **El cuidado de enfermería de Salud Comunitaria:** Proceso del cuidado de enfermería en la comunidad: Proyecto Comunitario de intervención, desarrollo social, inversión pública: Planificación, ejecución, supervisión y evaluación. Difusión de experiencias exitosas. Métodos abordaje comunitario: ASIS, Registro de Información comunal; Tácticas de abogacía. Asesoría a los colectivos.
- III. **Intervenciones socio – sanitarias para el desarrollo social sostenible:** Sistema de información comunal; Redes Sociales, Desarrollo y Cohesión Social; Control Social; Gestión Territorial. Participación Comunitaria. Los colectivos sociales: Instituciones educativas, laborales y organizaciones sociales. Educación y comunicación en salud comunitaria.

III.COMPETENCIAS

- CG: 2. Gestiona creativamente procesos orientados a la solución de problemas científicos, tecnológicos y humanísticos, aplicadas en un contexto interdisciplinario a través de la investigación e innovación.
- CEE 6. Es competente para cuidar integralmente a la persona, familia y comunidad en sus procesos de vida y salud para mejorar la calidad de vida, según enfoques y modelos teóricos de enfermería y ciencias afines, considerando el contexto y la participación de los actores sociales.
- CEE 7. Ejecuta Investigaciones que contribuyan a la solución de problemas de la población y de la disciplina considerando las prioridades regionales, nacionales e internacionales con perspectiva interdisciplinaria e intersectorial.
- CEE 9. Es gestor de programas de formación y actualización educativa dirigidos al personal de enfermería y grupos poblacionales, utilizando estrategias educativas pedagógicas y andragógicas innovadoras con enfoque interdisciplinario para mejorar el desempeño profesional y contribuir al desarrollo social.

DOCENTES DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR	ÁMBITOS DE PRÁCTICA
Dra. Violeta Fredesminda González y González	COMUNIDAD VISTA ALEGRE/HOSPITAL VISTA ALEGRE
Mg. Jenny Maria Estela Milla Risco	CENTRO DE SALUD UNION
Mg. Eliana Patricia Sandoval Salinas	CENTRO DE SALUD UNION



Visado

Dra. Rossina Dany de la Rosa Condormango	C.S. SAN MARTÍN
Dr. Tello Pompa Carlos Alberto	P.S. HUAMAN
Ms. Liliana del Carmen Torres Abanto	C.S. EL BOSQUE

PROGRAMACIÓN

Visado

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
PRIMERA UNIDAD: ENFOQUES TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICOS EN LA SALUD COMUNITARIA						
Valora a la comunidad en su proceso histórico de desarrollo social utilizando el proyecto comunitario con participación social, perspectiva gubernamental, transectorial y transdisciplinaria	Analizar y explicar los enfoques teóricos y políticas en la salud comunitaria	(T) Clase inaugural. Pre-test. Presentación del equipo docente. Presentación y Discusión del silabo. Conformación de los grupos de trabajo. Introducción: Enfoques teóricos y políticas en la salud comunitaria	Socialización del silabo. Resolver los saberes previos. Organización de los grupos colaborativos. Guía de aprendizaje 1 Video - foro Exposición oral -foro. Trabajo colaborativo	Participación del estudiante. Presentación y sustentación de Infografía.	Test de conocimientos Control de asistencia. Reporte de socialización del silabo. Rúbrica.	1 13- 15.08.2025
		(L) Plenaria sobre el marco epistemológico de la salud comunitaria	Investigación formativa (IF) Encuentro de grupos. Tarea 1: Presente Infografía sobre el tema.	Plenaria. Conclusiones. Retroalimentación. Entrega en el aula virtual	Rúbrica para evaluar la exposición. Rúbrica para evaluar infografía	
		(P) Reconocimiento del territorio donde se diseñará, ejecutará y evaluará el proyecto comunitario	Guía General de Práctica: Los escenarios de práctica (territorio). Colecta de información	Informe de reconocimiento del territorio	Rúbrica para evaluar el informe presentado.	
	Diferencia los modelos y teorías de desarrollo de enfermería en salud comunitaria	(T) Teoría y Modelos de Desarrollo y de Enfermería en Salud Comunitaria. Teoría de Desarrollo a Escala Humana. Teoría del Cuidado Cultural. Teoría del Desarrollo. Objetivos de Desarrollo Sustentable.	Guía de aprendizaje 2 Video - foro Exposición oral ilustrada. Sesión de preguntas y respuestas. Trabajo colaborativo (IF)	Participación del estudiante. Cuadro comparativo.	Registro de asistencia.	2 20- 22.08.2025
		(L) Plenaria sobre las teorías de desarrollo comunitario.	Encuentro de grupos. Tarea 2: Elabora cuadro comparativo	Presentación y exposición de cuadro comparativo.	Rúbricas	

		(P) Elaboración del Proyecto definitivo de Intervención Comunitaria/Estrategias Sanitarias Nacionales: Enfermedades metaxénicas y zoonóticas.	Guía General de Práctica Trabajo en equipo. Colecta de información requerida. Análisis de la información.	Trabajo en equipo. Presentación del informe de diagnóstico participativo. Preparación del Proyecto de RSU.	Rúbrica de evaluación del documento final.	
--	--	--	---	--	--	--

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
Elabora diagnóstico de enfermería socio sanitario para el cuidado de la comunidad en su proceso histórico de desarrollo social, utilizando enfoques de enfermería y sociopolítica	Analiza la importancia de incorporar los derechos humanos y el enfoque en las intervenciones de la salud comunitaria y elabora proyecto RSU.	(T) Derechos humanos y Enfoque de género en el trabajo comunitario. Consideraciones iniciales. Proyectos de desarrollo con dichos enfoques.	Guía de Aprendizaje 3 Video-foro Conferencia-foro: Derechos humanos y enfoque de género en el trabajo comunitario. Trabajo colaborativo.	. Escenificación sobre una intervención comunitaria donde se evidencie en enfoque de derechos humanos y el enfoque de género Elaboración del documento.	Registro de asistencia	3 Del 27-29.08.25
		(L) Plenaria sobre DD.HH. y enfoque de género	Encuentro de grupo Tarea 3. Elaboración de ensayo sobre el tema (I.F.).		Lista de cotejo	
		(P) Reconociendo las autoridades, instituciones y Actores sociales del territorio. (P) Elaboración del proyecto RSU: Participación del Establecimiento de Salud, Institución Educativa. ACS. Comunidad/Estrategias: Promoviendo la salud mental y cultura de paz.	Guía General de práctica Trabajo en equipo: Recojo de información. Revisión de estrategias del Programa. Socialización		Rúbrica	
	Analiza la importancia de las políticas públicas y el enfoque en las intervenciones de	(T) Política Nacional Multisectorial de salud al 2023 “Perú país saludable” Gestión de políticas Públicas. Modelo de cuidado como política pública.	Guía de aprendizaje 04 Presentación de video motivador Conferencia – foro: Trabajo colaborativo (I.F.)	Infografía sobre la Política Nacional	Registro de asistencia Rúbrica para evaluar la participación del estudiante.	4 03-05.09.25

	la salud comunitaria	(L) Plenaria. Estrategias y metas de la Política Nacional y la Enfermería Comunitaria.	Encuentro de grupo Socialización de los consensos Subir tarea 4 al aula virtual	Participación en plenaria	Rúbrica para evaluar foro de estudiantes	
		(P) Conociendo las estadísticas poblacionales y el perfil epidemiológico de la comunidad / ESN: Enfermedades no transmisibles.	Trabajo en equipo: Análisis de los problemas prioritarios de la comunidad (I.F.). Revisa las actividades pendientes e interviene.	Información recopilada según instrumentos Informe sobre avance de proyecto de intervención	Rúbrica Bitácora del programa	

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
Elabora diagnóstico de enfermería socio sanitario para el cuidado de la comunidad en su proceso histórico de desarrollo social, utilizando enfoques de enfermería y sociopolítica	Analiza la importancia de las políticas públicas y el enfoque en las intervenciones de la salud comunitaria	(T) La Agenda Nacional y Tendencias al Siglo XXI: Introducción y contexto. (Acuerdo Nacional)	Guía de aprendizaje 05 Video-foro Conferencia – foro Trabajo colaborativo (I.F.).	Infografía sobre Políticas Públicas y su repercusión en la Salud Comunitaria	Registro de asistencia Rúbrica para evaluar infografía	5 10-12.09.25
		(L) Plenaria. Socialización de los consensos	Encuentro de grupo Construcción de conclusiones Tarea 5. Subir al aula virtual la tarea de sesión.	Participación en la plenaria	Rúbricas	
		(P) Redacción del informe preliminar del Diagnóstico socio sanitario comunitario y preparación del Plan de Operaciones / ESN: Alimentación y Nutrición Saludable.	Trabajo en equipo: Análisis de los problemas prioritarios de la comunidad (I.F.). Revisa las actividades pendientes e interviene.	Información recopilada Informe sobre avance de proyecto de intervención	Rúbrica de Informe	
		Evaluación de la Unidad I	Evaluación de la Unidad I	Examen exitoso	Test conocimientos	



Visado

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
II UNIDAD: EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN SALUD COMUNITARIA						
Planifica los cuidados de enfermería a la comunidad en su proceso histórico de desarrollo social utilizando el proyecto comunitario con participación social, perspectiva gubernamental, transectorial y transdisciplinaria	Analiza las implicancias e interrelaciones de la política nacional multisectorial de salud 2030 en la enfermería salud comunitaria	(T) Salud Intercultural. Interculturalidad en salud. Consideraciones teóricas Implicancias para la Enfermería Comunitaria	Retroalimentación. Plan de Mejora. Guía de aprendizaje 06 Video-foro Conferencia Trabajo colaborativo (I.F.).	Propuesta de intervención de enfermería Infografía.	Rúbrica para evaluar infografía Rúbrica para evaluar la propuesta.	6 17-19.09.25
		(L) Plenaria. Socialización de los consensos	Aula invertida Elaboración de las conclusiones Tarea 6. subir al aula virtual la tarea de la sesión	Presentación de estrategias de salud intercultural	Rúbrica para evaluar la presentación de las estrategias de salud intercultural	
		(P1) Conociendo el ASIS de nuestro Establecimiento de Salud / ESN: Alimentación y Nutrición Saludable.	Trabajo de equipo Análisis de los problemas prioritarios de la comunidad (I.F.). Revisa las actividades pendientes e interviene.	Presentación del proyecto RSU	Rúbrica de evaluación del proyecto	
		(T) La ciudadanía en salud y la participación ciudadana en salud. Introducción. Definiciones. Factores que favorecen o propician una participación efectiva.	Guía de aprendizaje 07 Introducción Video-foro Conferencia – foro Trabajo colaborativo (I.F.).	Propuesta de participación ciudadana en salud en el proyecto de Responsabilidad Social Universitaria.	Registro de asistencia Rúbrica para evaluación de la propuesta	7 24-26-09..25
		(L) Construyendo la participación ciudadana y la ciudadanía en salud. Formas de lograrlo	Encuentro de grupo. Elaboración de las conclusiones Tarea 7. subir al aula virtual la tarea de la sesión	Dinámica de pequeños grupos (IF). Participación en la plenaria	Rúbrica de evaluación de la participación Rúbrica de auto y coevaluación	



Visado

		(P) Organizando el plan de trabajo en el ámbito de práctica / ESN: CRED	Trabajo de equipo Análisis de la información (I.F.). Revisa las actividades pendientes e interviene.	Presentación del plan de trabajo intra y extramuros.	Rúbricas	
Discute y reconoce la importancia de establecer acciones en salud que afronten el cambio climático		(T) El cambio climático. Enfermería, cambio climático y salud. Plan Andino de salud y cambio climático.	Guía de aprendizaje 08 Video-foro Conferencia - foro. Trabajo colaborativo	Propuesta de intervención de enfermería frente al cambio climático.	Registro de asistencia. Rúbrica para evaluar la propuesta	8 01-03-10.25
		(L) Enfrentando el cambio climático	Encuentro de grupo. Elaboración de las conclusiones Tarea 8. subir al aula virtual la tarea de la sesión.	Dinámica de pequeños grupos (IF). Participación en la plenaria	Rúbricas	
		(P) Implementando de Plan Alternativo para el enfrentamiento del Cambio Climático/ESN	Trabajo de equipo Análisis de la información (I.F.). Revisa las actividades pendientes e interviene.	Implementando el Consultorio de Salud Escolar y las ESN.	Rúbricas	
	Identifica las interrelaciones entre la Salud Ambiental y la Enfermería en Salud Comunitaria	(T) Salud Ambiental y Enfermería Comunitaria. Generalidades. Estrategias para su implementación.	Guía de aprendizaje 08 Video-foro Conferencia - foro. Trabajo colaborativo	Propuesta de intervención de enfermería en Salud Ambiental.	Rúbricas	9 08.10-10.25
		(L) Implementando la Salud Ambiental	Encuentro de grupo. Elaboración de las conclusiones Tarea 9. subir al aula virtual la tarea de la sesión.	Dinámica de pequeños grupos (IF). Participación en la plenaria	Rúbricas	
		(P) Actividades preventivo promocionales en el Consultorio de Salud Escolar/ESN: Control de TBC y VIH	Trabajo de equipo Análisis de la información (I.F.). Revisa las actividades pendientes e interviene.	Implementando el Consultorio de Salud Escolar y las ESN.	Rúbricas	
Diseña y ejecuta planes y proyectos socio sanitarios para la comunidad	Reconocer la importancia del enfoque de abogacía en las	(T) El enfoque de abogacía en promoción de la salud comunitaria El significado de Abogacía en salud comunitaria. La	Guía de Aprendizaje N° 10 Video-foro: Conferencia-foro Trabajo colaborativo (IF)	Planes de abogacía en promoción de la salud. Informe ejecutivo	Registro de asistencia Rúbrica de evaluación de informe Matriz registrada	10 15-17.10.25



Visado

proceso con participación social, perspectiva gubernamental transectorial y transdisciplinaria	actividades de promoción de la salud	construcción de la estrategia. Casos.				
		(L) Preparando un proyecto con enfoque de Abogacía.	Encuentro de grupo. Elaboración de las conclusiones Tarea 10. subir al aula virtual la tarea de la sesión.	Revisar la información Los grupos hacen los planes de abogacía	Rúbrica de autoevaluación y coevaluación	
		(P) Continuando el Proyecto RSU FACENF / ESN: Inmunizaciones	Trabajo de equipo Análisis de la información (I.F.). Revisa las actividades pendientes e interviene.	Medios y materiales elaborados y validados	Rúbrica de evaluación del proyecto RSU	
	Analiza los programas sociales que se vienen implementando en el Perú y su contribución con la salud comunitaria	(T) Programas Sociales en el Perú: Programas sociales: Qué son, importancia y su impacto. Principales programas sociales: Cuna Más, Qali Warma, JUNTOS, Becas 18, Programa PAÍS (PIAS y TAMBOS), Contigo, FONCODES (Haku Wiñay-Noa Jayatai), Pensión 65, el programa “Mujer Emprendedora”, Caminos vecinales, Agua y saneamiento rural, Electrificación rural, Telecomunicaciones rurales y Casitas calientes y seguras ante las heladas. Los programas sociales y el rol de la enfermera comunitaria	Guía de aprendizaje 11 Presentación del evento – Sociodrama/Desempeño de roles Interacción docente-estudiante: Sesión de preguntas y respuestas. Trabajo colaborativo (IF)	Feria de programas sociales, precisando los grupos objetivos, beneficios que ofrece y su articulación con el sector salud y el rol de la enfermera comunitaria.	Rúbricas	11 22.24- 10-.25
		(L) Trabajo colaborativo: Feria de los Programas Sociales.	Encuentro de grupo. Elaboración de las conclusiones Tarea 11. subir al aula virtual.	Dinámica de pequeños grupos / presentación del producto	Rúbricas	
		(P) Continuando el Proyecto RSU FACENF / ESN: Inmunizaciones	Trabajo de equipo Análisis de la información (I.F.).	Medios y materiales elaborados y validados	Rúbrica de evaluación del proyecto RSU	



Visado

			Revisa las actividades pendientes e interviene.			
		Evaluación de la II Unidad	Evaluación escrita de la Unidad	Examen resuelto	Test de conocimientos	

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
III. IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO COMUNITARIO						
Utiliza tecnologías para los planes y proyectos dirigidos al desarrollo de la comunidad con participación social	Analiza el aporte de la gestión comunal, redes sociales y participación social en la salud y desarrollo de su territorio asignado.	(T) Cuidado Territorial: La enfermera como gestora de salud comunitaria o territorial y participación social	Plan de Mejora II Unidad Guía de aprendizaje 12: Video - Foro Conferencia – discusión Trabajo colaborativo (IF)	Plan de Trabajo del Territorio asignado.	Registro de asistencia Rúbrica de evaluación de infografía Informe de actividades realizadas	12 29.31-10.25
		(L). Preparando un plan de trabajo en el territorio	Encuentro de grupo. Elaboración de las conclusiones Tarea 12. subir al aula virtual			
		(P) Prosigue el Proyecto RSU FACENF/Viaje de Observación e Intercambio estudiantil a la Universidad Nacional de Cajamarca – Filial Jaén	Guía General de Práctica Ejecución de actividades programadas del proyecto comunitario.	Actividades Ejecutadas	Rúbrica de autoevaluación y coevaluación Informe de Visita de Observación	
	Evaluará el contexto, el	(T) Evaluación de los proyectos de intervención. Fases de Evaluación.	Video-foro. Conferencia-discusión Trabajo colaborativo (IF).	Informe de evaluación del proyecto de intervención.	Rúbricas Rúbricas	13 05.07-11.25
		(L) Elaboración de informe de evaluación del proyecto de intervención	Taller de evaluación y presentación del informe final de proyectos de intervención comunitaria.			
		(P) Implementación, ejecución, evaluación y difusión del	Guía General de Práctica Trabajo colaborativo:	Informe Final		



Visado

	proceso y el logro de los proyectos de intervención comunitaria.	Informe/ESN: Salud Ocular y prevención de la ceguera	Elaboración del informe del proyecto comunitario.			
		(T) Presentación y sustentación del Informe	Introducción Presentación y sustentación del informe-cierre del Proyecto	Informe final		14 12.14-11.25
		(L) (P) Preparación de la Feria de Experiencias de Enfermería en Salud Comunitaria	Comunicación a través de las redes sociales: Facebook, Instagram, tik tok, etc.			
		(T) Difusión de los Resultados del Proyecto Comunitario. Feria de Salud.	Elaboración del plan de difusión del informe del Proyecto Comunitario. Colocación en redes sociales: YouTube, Facebook del DASFC u otros.	Informe del Proyecto Video de difusión en redes sociales	Registro de asistencia Rúbrica de auto y coevaluación. Rúbrica para evaluar la Feria de Salud.	15 19.21-11.25
		Examen de Rezagados. Examen Teórico y Práctico III Unidad: Feria de Salud.	Evaluación de III Unidad	Registro de evaluación	Presentación y exposición	16 26.28-11.25

TEMA DE EVALUACIÓN

Visado

Base Legal: Reglamento de Normas Generales de Evaluación del Aprendizaje de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

5.2. Procedimientos

1. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN SILÁBICA

Para determinar el desempeño de lo previsto y recoger información sobre problemas del proceso de aprendizaje, y buscar alternativas viables para mejorar el desarrollo de la asignatura.

2. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE. Se consideran tres tipos:

2.1. Evaluación diagnóstica: Se aplicará antes de iniciar la experiencia curricular, para obtener información del conocimiento en relación a pre-requisitos y contenidos de la asignatura, que permita realizar reajustes en la programación silábica.

2.2. Evaluación formativa: Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, mediante la observación, aplicación de reactivos orales, entrevistas a los estudiantes y otros. Se realizará la retroalimentación oportuna.

2.3. Evaluación Sumativa: Se realizará a través de exámenes teóricos (3), presentación y sustentación oportuna de trabajos asignados y el desempeño en la práctica en campo. Nota aprobatoria final de catorce (14). El artículo 113 del Estatuto Vigente es aplicable en el Promedio Final (13.5).

Los exámenes se realizarán en las fechas programadas a través de pruebas escritas sobre los contenidos de las unidades utilizando una escala de calificación para el proyecto de intervención y proyección social. Los resultados serán conocidos por las (los) estudiantes en la clase siguiente de ser rendidos, dando oportunidad para la realimentación correspondiente.

2.4. Para ser promovidos en el curso:

- Es condición indispensable para ser apto a evaluación promocional, acreditar una asistencia mínima del 70 %. Más del 30 % de inasistencias, inhabilita al estudiante y no tiene derecho a rendir examen de aplazado. No se aceptará justificación de inasistencia a las prácticas, toda inasistencia será recuperada en un horario extraordinario según el tiempo contemplado para lograr las metas de su trabajo individual y/o grupal. Dicho horario no se extenderá más allá de la fecha de término de la práctica respectiva.
- Haber rendido todas las evaluaciones y aprobado dos unidades como mínimo.

2.5. Examen de Rezagados:

- La (el) estudiante que, por causa justificada, debidamente comprobada no se haya presentado a los exámenes programados, tendrá derecho a rendir examen de rezagados; para lo cual la (el) interesada (o) deberá presentar en término de 48 horas, una solicitud adjuntando el documento de justificación dirigida a la Directora del Departamento de Salud Familiar y Comunitaria; de no hacerlo se considerará nota cero (0) para efectos del promedio.

2.6. Examen Sustitutorio

- El examen sustitutorio se efectúa cuando el estudiante tiene nota desaprobatoria, menos de catorce (14) puntos, en una unidad o en el promedio final de la asignatura. En este caso se busca que con este examen reemplace el calificativo desaprobatorio y mejore su nota promocional.
- El examen sustitutorio se ejecuta a solicitud (mediante FUT) del estudiante desaprobado dirigido al docente responsable del curso o, de manera obligatoria, por parte del docente cuando hay un porcentaje mayor al treinta (30) por ciento de desaprobados en una Unidad o en el promedio final de la asignatura.
- El examen sustitutorio, preferentemente, se organiza y ejecuta en la última semana de la programación del semestre académico (semana dieciséis).
- El examen sustitutorio corresponde a una Unidad de Aprendizaje. Solo se pueden rendir este tipo de examen en la Unidad de más bajo calificativo.
- El calificativo que obtenga el estudiante en el examen sustitutorio reemplazará a la nota de la Unidad desaprobada.
- Si a pesar del examen sustitutorio, el estudiante siguiera obteniendo, por segunda vez, nota promocional desaprobada, pasa a una evaluación de aplazados.
- El calificativo del examen de aplazado será promediado con la última nota promocional. Si aun así saliera desaprobado, el estudiante debe repetir la asignatura.

2.7. Distribución Porcentual por Aspectos a evaluar:

Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado

aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, planes de intervención, entre otros); y sirve para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los estudiantes y autoridades para las acciones de mejora respectiva.

Al valorar los resultados y/o productos se debe de tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados: prueba escrita, rúbrica de evaluación (proyecto, informe, mapa conceptual, ensayo, infografía), lista de cotejo, línea de tiempo entre otros.

Los exámenes se han programado en el silabo a través de pruebas escritas y /o práctico por unidades, presentación y sustentación de informes por unidades. Los resultados serán conocidos por los estudiantes en la clase siguiente de ser rendidos.

- **PONDERACIÓN DEL PROCESO EVALUATIVO**

1. TEORÍA	30 %
- 1.1. Examen escrito de Unidad	15 %
- 1.2. Informes de trabajos individuales y grupales y sustentaciones	05 %
- 1.3. Participaciones efectivas en trabajo de grupo y plenarias	10%
2. PRACTICA:	60 %
- Preparación, presentación, sustentación, implementación, ejecución,	
- Evaluación del Proyecto e Informe de Desarrollo Comunitario (RSU)A)	20 %
- Informes, bitácora, trabajo encargado	15 %
- Autoevaluación/coevaluación	10%
Portafolio	15 %
3. ACTITUD: Responsabilidad, puntualidad, asistencia	10%

- La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional correspondientes

$$PP= PUI + PUII + PUIII / 3$$

NIVEL DE LOGROS: Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

Valoración integral de la competencia a través de las evidencias de desempeño de los estudiantes obtenidos al finalizar la experiencia curricular. Se establece tres niveles de logro:

Nivel de inicio: Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0-13)

Nivel logrado: Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la experiencia curricular. (14-17)

Nivel Avanzado: Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la experiencia curricular. (18-20)

Al final de cada Unidad de aprendizaje se implementarán acciones correctivas (retroalimentación), para aquellos estudiantes que se encuentren en los niveles de inicio.

METODOLOGIA DE TRABAJO POLIDOCENTE.

- Cada profesor del equipo de docentes contará con su respectivo grupo, donde desarrollará la parte teórica y de laboratorio de la experiencia curricular en el aula asignada.
- La presente experiencia curricular, tendrá 3 sesiones semanales una sesión de 3 horas que, incluye la teoría y otra de 2 horas de laboratorio; esta incluye el trabajo en grupo o por pares, según el caso, además de la retroalimentación de dicha sesión, además de dos sesiones de práctica de cinco horas cada uno, las cuales incluirán el desarrollo del proyecto comunitario (Proyecto RSU) y las Estrategias Sanitaria Nacionales.
- Después de rendir el examen de cada unidad, se hará una retroalimentación de los temas tratados, además de dar a conocer los resultados del mismo. El examen de la última Unidad consistirá en la preparación, planificación, organización, implementación, ejecución y evaluación de la Feria de Enfermería en Salud Comunitaria.

docentes coordinadores, harán la evaluación cuantitativa y cualitativa de la ejecución de la experiencia curricular según unidades y emitirán su informe, la cual será canalizada a la Dirección del Departamento Académico de Salud Familiar y Comunitaria.

- La preparación de las Guías de Aprendizaje se ha realizado con el aporte de los todos los docentes participantes en la experiencia curricular, incluyendo las filiales, las mismas que serán socializados entre todos ellos, la semana anterior a la clase que corresponde y sustentados en el Departamento Académico de Salud Familiar y Comunitaria.
- En el desarrollo de la experiencia curricular, se prevé reuniones periódicas, para esclarecer dificultades o limitaciones, consolidar estrategias, consensuar algunas situaciones que ameriten un acuerdo general o una decisión conjunta.

VI: TUTORÍA ACADÉMICA (Plan de mejora)

6.1. Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

Estrategia de presentación del servicio:

Se dará a conocer la estrategia desde el primer día de clase, la cual considera reuniones presenciales individuales y grupales para planificar aspectos de la Responsabilidad Social que se desarrollará en el presente ciclo académico

Lugar y horario semanal para la consejería extra-clase:

Durante todo el desarrollo del curso, según el horario declarado en la carga horaria y se realizará en forma presencial 2025-II en las oficinas de los docentes.

6.1.1. Desarrollo de la Tutoría

Docentes	Sección	Día y Hora	Lugar	E – mail institucional
Dr. Carlos Alberto Tello Pompa	"1"	Declarado en otro curso	-----	ctello@unitru.edu.pe
Dra. Violeta Fredesmina González y González	"1"	.5-6pm Martes	Oficina 2 2do.piso	vgonzalez@unitru.edu.pe
Ms. Eliana Patricia Sandoval Salinas	"1"	Miércoles 1 pm	Oficina 2 2do. piso	Esandoval @unitru.edu.pe

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Andía Valencia, W. (2023) *Manual de gestión pública. Pautas para la aplicación de los sistemas administrativos*. Ediciones Arte y Pluma.
- Andía Valencia, W., & Andía Chávez, J. (2010) *Manual de gestión ambiental*. Centro de Investigación y Capacitación Empresarial.
- Artica, R.E. (2015) Principales problemas de las políticas públicas en materia de seguridad vial y la atención integral de las víctimas de accidentes de tránsito en Lima Metropolitana en los años 2012 al 2013
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/6692/ARTICA_SOTOMAYOR_RAUL_ERNESTO_PRINCIPALES.pdf?jsessionid=AE8ECD410F5007E076F8FCE39BB3B72C?sequence=1
- Ayuso, D., Tejedor, L., & Serrano, A. (2015) *Enfermería Familiar y Comunitaria. Actividad asistencial y aspectos ético-jurídicos*. España: Ediciones Díaz de Santos.
- CARE Perú. (2012). Sistema de Vigilancia Comunitaria. Pp 66.
<http://www.care.pe/pdfs/cinfo/libro/guia%20sivico%20completa%2004%2012%2006.pdf>
- CEPAL. (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Naciones Unidas. Pp. 127.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y Sociales. Informe Especial COVID-19
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/6/S2000264_es.pdf



io de la República del Perú (2021). Presupuesto de los programas sociales. Lima Perú
<https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/2021-rep-tematicos/rt-99-presupuesto-programas-sociales-cargo-minist-desarrollo-e-inclusio-social%E2%80%9393midis.pdf>

Visado

- Esmel, N., Rodríguez, P., Daza, B., & Mejía, S. (2022) *Enfermería Integrativa. Manual práctico*. Bs. As. Editorial Médica Panamericana.
- Flores, M. (2019) *Filosofía intercultural y el Allin Kawsay (vivir bien andino) en el diálogo de razones*. . editorial San Marcos.
- Fuentes-García, A. (2018). Editorial GÉNERO Y SALUD PÚBLICA. Revista Chile Salud Pública 2018, Vol 22(2): 113-114.
<http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7031/LIBENcoman.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gobierno Peruano. (2020). Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 “Perú País Saludable. El Perú Primero.
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/374690/version-preliminar-de-la-politica-nacional-multisectorial-de-salud.pdf>
- Gutiérrez, V; Coaquira; N; Rondón , M; (2018). Salud Familiar y Comunitaria(Tendencias). Lima Perú
<http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7031/LIBENcoman.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Hernández, M., Lazcano, E. (2013) *Salud Pública. Teoría y práctica*. Colombia: El Manual Moderno.
- Ishikane, G.A. (2017) Gestión Municipal. Percepción ciudadana. Mauritius: Editorial Académica Española.
- López Lara, R. (2018). El análisis de situación de salud poblacional en América Latina y el Caribe, entre 2000 y 2017. Reflexiones y desafíos. Revista Facultad Nacional De Salud Pública, 36(3), 18–30.
<https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.v36n3a03>
- Lossio, J. (2017). Salud Publica en el Perú del Siglo XX. Paradigmas, discursos y políticas. Primera edición. Publicaciones del Instituto Riva- Agüero N°324. Pontificia Universidad Católica del Perú.
<https://ira.pucp.edu.pe/biblioteca/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/Salud-publica-en-el-peru-del-siglo-XX.pdf>
- Martín Zurro, A., & Jodar Solá, G. (2018) *Atención Familiar y Salud Comunitaria*. Elsevier.
- Martínez Riera, J.R., & Del Pino Casado, R. (2014) *Manual Práctico de Enfermería Comunitaria*. Elsevier.
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. (2018). La Gobernanza Territorial para el Desarrollo: Organización del estado multinivel para los ciudadanos.
http://www.midis.gob.pe/conectandofuts/wpcontent/uploads/2018/11/Ra%C3%BAI-Molina_Viceministro-de-Gobernanza-Territorial-de-la-PCM.pdf
- Ministerio de Salud. (2018). Pocket de gestión del riesgo de desastres aplicado al sector salud”. Lima. Vol.2. Lima.
<http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4628.pdf>
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2017). Conceptos fundamentales para la transversalización del enfoque de género. Lima. 2ª edición - Diciembre de 2017. 12 pp.
<https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/Folleto-Conceptos-Fundamentales.pdf>
- Ministerio de Salud – MINSA (2015) Metodología para el análisis de situación de salud local. DOCUMENTO TÉCNICO.
<http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3399.pdf>
- Ministerio de Salud- MINSA. (2020). Indicadores Básicos Nacionales: Sala situacional COVID-19 Lima Perú
<https://www.dge.gob.pe/Asis/indbas/2020/nivnacional.pdf>
- Ministerio de Salud -MINSA (2021). Principales programas y servicios sociales en el Perú
<http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/5401.pdf>
- Molina Jaramillo, A. (2018). Territorio, lugares y salud: redimensionar lo espacial en salud pública. Cad. Saúde Pública 2018; 34(1):e00075117. Disponible en:
<https://www.scielo.org/article/csp/2018.v34n1/e00075117/>
- OMS / UNICEF. (2020).Atención de la Salud comunitaria incluida la divulgación y las campañas en el contexto de la pandemia de COVID-19
<https://www.unicef.org/media/73136/file/Community-based-health-care-SP.pdf>
- Ortegón, E., Pacheco, J.F. & Prieto, A. (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Serie Manuales CEPAL. Naciones Unidas, Santiago de Chile (reimpresión de abril de 2015). Pp. 124. ISSN 1680-886X
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf
- Oxfam (2014). CAJA DE HERRAMIENTAS DE GÉNERO Módulo 1: Formación básica en género - Manual para participantes.
https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fpublic/file_attachments/Manual%20participantes%20-%20M%C3%B3dulo%201%20Formaci%C3%B3n%20b%C3%A1sica%20en%20g%C3%A9nero_2.pdf



Pin, V., Vélez Macías, M., Jaime Hernández, N.; Vélez Franco, M. (2020) Importancia de la atención primaria de la salud en la comunidad. DOI: 10.26820/reciamuc/4.(3).julio.2020.367-374.

Visado

<https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/535/840>

Pontificia Universidad Católica del Perú. (2021). Protección social y lucha contra la pobreza

https://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/wp-content/uploads/2021/05/8_dp_proteccion_social_pobreza.pdf

Preciado (2018) Enfermería cultural. Una mirada antropológica del cuidado. Madrid: Garceta Grupo Editorial.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. (2020). Vulnerabilidad en los hogares y acceso a salud. Lima Perú Págs.:

<https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/pe/40bbd1df6974a352b64c9d6677c36e6d2c06f2b74021eadc745ea4ebab3be6d9.pdf>

Rodríguez, J.J. (2009) *Salud mental en la comunidad*. (2ª.ed.) OPS/OMS.

Rodríguez, R. (2017). Los orígenes de la enfermera comunitaria en Latino américa

<https://www.redalyc.org/journal/3438/343855203009/htm>

Santos, G; Torres; Capcha, L; García, G; Infante, E. (2017). Experiencias de Aprendizaje en Salud Comunitaria en estudiantes de Enfermería. Universidad Mayor de San Marcos. Lima Perú

https://www.scielo.br/pdf/reben/v72n4/es_0034-7167-reben-72-04-0841.pdf

Tisnés, A. (2014). Espacio y Salud: Teoría, Técnicas y Conceptos. Una aproximación a la evolución temporal de la geografía de la salud. GEOGRAFIA EM QUESTÃO V.07 ♦ N. 02. ISSN 2178-0234. Pp. 74-99. Disponible en:

<http://saber.unioeste.br/index.php/geoemquestao/article/viewFile/9258/7674>

Trujillo, 4 agosto del 2025.

Dra. Violeta Fredesminda González Y González

Coordinadora Grupo 1

Vº Bº PLAN DE MEJORA

EXPERIENCIA CURRICULAR:



IVO: Realizar el acompañamiento cognitivo y socio afectivo del estudiante, para contribuir al logro de las metas terminales no logradas.

Visado

PERIODO DE UNIDAD: ____ (I) ____ (II) ____ (III)

Capacidad terminal no lograda por el estudiante	Situación problemática del estudiante	Intervención pedagógica	Acciones de acompañamiento o académico	Derivación	Evidencias
			- Virtual - Presencial	- Bienestar universitario. - Dpto. psicológico	Registros de atención al estudiante

Docente

Director de Escuela